

NephroAssist — Pitch Deck

La prima piattaforma italiana dedicata alla valutazione pre-trapianto e alla coordinazione dei pazienti

Per investitori e partner strategici | Agosto 2026

Slide 1: Copertina — Il Gancio

NephroAssist

Meno telefonate, meno carta, più pazienti pronti per il trapianto.

La prima piattaforma italiana dedicata alla valutazione pre-trapianto e alla coordinazione dei pazienti

Note per il relatore: Benvenuti. Sono [Nome], fondatore di NephroAssist. Oggi vi mostrerò perché il percorso più complesso in medicina — la strada verso il trapianto di organo — è ancora gestito con Excel, telefonate e post-it. E come noi chiudiamo questa lacuna. Non è un'idea nata nel Silicon Valley. È un problema che i coordinatori dei trapianti vivono ogni giorno.

Slide 2: Il Problema — La Crisi della Coordinazione Trapianti

Il percorso pre-trapianto più complesso in medicina gira su fogli di calcolo.

- ~40 centri trapianti di rene attivi in Italia
- ~8.000 pazienti in lista d'attesa per il rene
- ~3.000–3.500 trapianti di rene all'anno
- I coordinatori gestiscono **40–60 pazienti** contemporaneamente nella fase di valutazione
- **10+ ore/settimana** perse a rincorrere documenti e ricordare appuntamenti
- Appuntamenti persi e valutazioni incomplete **ritardano l'inserimento in lista di settimane o mesi**
- **Nessuno strumento dedicato esiste** per la coordinazione pre-trapianto in Italia

«Gestiamo tutto su Excel. Quando un coordinatore è assente, nessuno sa dove stanno le cose.» — Coordinatore dei trapianti, centro accademico italiano

Note per il relatore: Il coordinatore dei trapianti è la figura non chirurgica più importante dell'intero processo. Coordina la valutazione, la raccolta dei documenti, la pianificazione degli appuntamenti e la comunicazione con il paziente — spesso per 40–60 pazienti contemporaneamente. E gli strumenti? Excel, telefono, email. Questo non è un problema di workflow. È un problema di sicurezza del paziente. Ogni settimana di ritardo significa più tempo in lista d'attesa. È tempo di vita.

Slide 3: La Soluzione — NephroAssist

La prima piattaforma che si colloca tra il fascicolo sanitario elettronico e il paziente — dedicata al trapianto.

Cosa fa: - Liste di controllo intelligenti per la valutazione pre-trapianto (rene → cuore, fegato, polmone) - Chat sicura in tempo reale tra paziente e coordinatore (non solo telefono come CareDx) - Raccolta e revisione documenti automatizzata - Promemoria per l'assunzione dei farmaci con visibilità per il care team - Educazione del paziente lungo il percorso pre-trapianto

Come si integra: - Avvio SMART on FHIR da Epic/Cerner — legge esami, appuntamenti, dati demografici - Posizionata come **strato di coordinazione**, non come sostituto del FSE - GDPR Art. 9 pronto; DPIA completata; hosting UE

Note per il relatore: Non sostituiamo il fascicolo sanitario elettronico. Lo completiamo. NephroAssist è lo strato che manca: tra il sistema clinico (Epic, Cerner) e il paziente. Diamo al coordinatore una dashboard che mostra dove si trova ogni paziente. Diamo al paziente un'app che gli dice cosa fare dopo. Non è un'innovazione tecnologica — è una scelta di design. Abbiamo pensato al percorso dal punto di vista del coordinatore, non del CIO.

Slide 4: Prodotto — Quattro Strati di Valore

Strato 4: Intelligence & Analytics

– Dashboard del coordinatore, tassi di completamento, metriche time-to-listing, reportistica CNT-ready

Strato 3: Motore di Workflow Trapianto

– Liste di controllo per organo, revisione documenti, catene di approvazione, audit

Strato 2: Coordinazione Dialisi & Pre-

Trapianto – Pianificazione appuntamenti, tracciamento esami, gestione ricoveri, chat del care team

Strato 1: Strato di Esecuzione per il

Paziente – PWA mobile, liste attività, promemoria farmaci, contenuti educativi, tracciamento progressi

MVP (Mesi 1–6): Strato 1 + 2, solo rene **Fase 2 (Mesi 6–18):** Cuore, fegato, polmone; workflow donatore vivente **Fase 3 (Mesi 18–36):** Personalizzazione AI, espansione EU, automazione CNT

Note per il relatore: La nostra architettura è deliberatamente stratificata. Lo strato più basso è l'app del paziente — quello che il paziente vede. Sopra, lo strato di coordinazione per il care team. Sopra ancora, il motore di workflow con liste di controllo e approvazioni. In cima, lo strato analytics che mostra al direttore del programma quanto velocemente i pazienti completano la valutazione. Partiamo dal rene perché rappresenta il 70% di tutti i trapianti d'organo solido. Questa è la nostra spiaggia.

Slide 5: Mercato — Nichia, Sticky, Sottoservito

Metrica	Valore	Fonte
Centri trapianti di rene attivi (IT)	~40	Centro Nazionale Trapianti (CNT)
Pazienti in lista d'attesa rene (IT)	~8.000	CNT / Ministero della Salute
Trapianti di rene annuali (IT)	~3.000–3.500	CNT / Eurotransplant
Programmi EU+UK	~250–300	Eurotransplant + NHSBT
Trapianti annuali EU+UK	~17.000+	Eurotransplant + NHSBT

Mercato Addressable (Italia): - TAM a €5K–€50K/centro/anno: **€200K–€2M annuali** - EU+UK raddoppia il conteggio dei programmi - Post-trapianto adherence, coordinazione donatore vivente e moduli pediatrici estendono il TAM

Perché questo mercato vince: - Sticky: i centri trapianti cambiano raramente strumenti a metà ciclo - Mission-critical: i ritardi nell'inserimento in lista influenzano direttamente la sopravvivenza del paziente - Attualmente servito da moduli FSE/EHR con lacune di usabilità note - **Nessun concorrente diretto** in Italia nella coordinazione pre-trapianto

Note per il relatore: Non è un mercato da miliardi. È una scelta deliberata. Puntiamo a una nicchia ad alto valore, appiccicosa e sottoservita. 40 centri in Italia. Altri 250–300 in Europa. Un singolo contratto Enterprise a €30K–€50K/anno è redditizio — e i centri non cambiano ogni due anni. Il tasso di abbandono è basso perché i dati dei pazienti devono essere migrati e i coordinatori devono essere riaddestrati. Questo è un fossato difensivo.

Slide 6: Modello di Business — Land-and-Expand B2B SaaS

Tier	Target	Prezzo Annuale	Scope
Free	Pazienti singoli e caregiver	€0	Lista personale, promemoria, educazione
Starter	Piccoli centri (≤50 pazienti)	€2.999/anno	Dashboard coordinatore, template, analytics base
Professional	Centri medi (≤200 pazienti)	€7.999/anno	Chat care team, integrazione FHIR, workflow custom
Enterprise	Grandi sistemi sanitari / Aziende Ospedaliere	€20K–€50K/anno	Illimitato, SSO, SLA, CSM dedicato, integrazioni custom

Logica di pricing: - Tutti i concorrenti usano vendite enterprise opache — il pricing trasparente è un differenziatore di fiducia - Il tier Starter è abbastanza basso da aggirare l'approvazione del comitato in alcuni centri - Enterprise prezzato 20–40% sotto piattaforme generiche equivalenti per vincere il displacement

Freemium Flywheel: App paziente gratuita → inviti virali del coordinatore → trial → conversione a pagamento

Note per il relatore: Il nostro pricing è trasparente — è una scelta deliberata. Ogni concorrente in questo spazio vende tramite contratti enterprise opachi. Noi mostriamo i prezzi sul sito. Questo abbassa la soglia di ingresso per i centri più piccoli e costruisce fiducia. Il flywheel freemium funziona così: un paziente usa l'app gratuita, la menziona al suo coordinatore, che si registra, e noi convertiamo in un account a pagamento. Nessun marketing a pagamento necessario.

Slide 7: Traction & Readiness del Pilota

Stato attuale: - Codebase Next.js esistente con workflow paziente/caso/compito - Pipeline di upload e revisione documenti - Dashboard e viste analytics - UI PWA-ready Bootstrap 5.3

Lacune di sicurezza e compliance in chiusura: - Middleware JWT Bypass (P0) — fix in corso - Hardcoded Fallback Secret (P0) — fix in corso - Rate Limiting (P0) — implementazione pianificata - Engagement audit SOC 2 Type II: obiettivo Mese 3

Strategia pilota Italia: - Target: 1 centro accademico + 1 centro di comunità per diversità - Pilota di 90 giorni con metriche di successo definite (tasso completamento liste, tempo risparmiato coordinatore) - Contratti manuali; nessun self-serve billing necessario per i primi ricavi - **Export CNT-ready** per la reportistica al Centro Nazionale Trapianti

Note per il relatore: Abbiamo già un prototipo funzionante. Workflow paziente, gestione documenti, dashboard — tutto presente. Quello che stiamo chiudendo sono le lacune di sicurezza che ci separano da un pilota con veri dati sanitari. Non è un "ci vogliono 6 mesi di sviluppo". È un "ci vogliono 4–6 settimane di hardening della sicurezza". Il primo pilota può iniziare al Mese 3. E in Italia, l'export CNT-ready è un vantaggio competitivo unico: nessun altro strumento generico può generare report già formattati per il Centro Nazionale Trapianti.

Slide 8: Vantaggio Competitivo — Perché vinciamo

1. **Profondità di dominio:** L'unica piattaforma costruita per il percorso pre-trapianto a 5 stadi (considerazione → selezione centro → valutazione/lista → attesa → offerta/OP)
 2. **First-mover nella lacuna:** Nessun concorrente combina liste di controllo specifiche per trapianto + chat in tempo reale paziente-coordinatore + workflow documentali
 3. **Architettura compliance-first:** GDPR Art. 9 pronto dal giorno 1; DPIA completata; gestione consenso granulare — nessun concorrente generico offre questo livello
 4. **Integrazione, non sostituzione:** Avvio SMART on FHIR da Epic/Cerner riduce l'attrito di approvvigionamento rispetto al rip-and-replace
 5. **Design coordinatore-first:** Costruito per il dolore quotidiano, non per la checklist del CIO
 6. **Vantaggio Italia-specifico:** Primo strumento nativamente italiano per la coordinazione pre-trapianto; export CNT-ready; conformità GDPR con hosting UE
-

Note per il relatore: Il nostro vantaggio competitivo non è una singola funzionalità. È la combinazione di profondità di dominio, compliance e filosofia di design. CareDx è profondo nel trapianto, ma non ha un'app paziente. SeamlessMD ha un'app paziente, ma non ha la specializzazione trapianto. Epic ha tutto, ma i coordinatori si lamentano dell'usabilità. Noi siamo gli unici a servire esattamente questa lacuna: coordinazione pre-trapianto, patient-facing, compliance-ready. E in Italia, siamo i primi — questo è un fossato difensivo enorme.

Slide 9: Team & Visione

Founder-led, domain-informato, compliance-first.

Il team unisce esperienza prodotto in Healthcare SaaS con profonda conoscenza del workflow del coordinatore dei trapianti. Lo stack tecnico (Next.js, PostgreSQL, Prisma, Bootstrap) è collaudato in produzione ed evolvibile.

Visione:

Ogni paziente in attesa di trapianto, ovunque nel mondo, dovrebbe avere un percorso chiaro e tracciabile dalla presa in carico al trapianto — e ogni coordinatore dovrebbe sapere esattamente dove si trova ogni paziente, senza aprire un foglio di calcolo.

Prossimi traguardi: - Mese 3: Prima clinica pilota live - Mese 6: Primo cliente pagante - Mese 12: SOC 2 Type II + 10 clienti paganti - Mese 18: Primo contratto Enterprise + integrazione FHIR read - Anno 2: Espansione multi-organo + ingresso nel mercato EU

Note per il relatore: Non siamo un team di consulenti McKinsey che ha scritto un pitch deck per un settore che non conosce. Abbiamo incorporato feedback diretto dai coordinatori dei trapianti. La visione è semplice: nessun paziente dovrebbe essere dimenticato in lista d'attesa perché un documento si è perso in una email. Questo è tecnicamente risolvibile. È un problema di design.

Slide 10: Proiezioni Finanziarie — Tre Scenari

Ricavi 24 mesi (Modello Zero-Bootstrap):

Scenario	Ricavo A1	Ricavo A2	Totale 24-Mo
BEAR (30%)	€2.750	~€0	€2.750
BASE (50%)	€14.835	€98.838	€113.673
BULL (20%)	€83.688	€403.026	€486.714
Risk-adjusted expected			€155.005

Ipotesi chiave: - Solo founder, nessun marketing a pagamento (CAC ≈ €0) - Costi infrastruttura: €70–€120/mese - Churn mensile: 3–8% (Starter/Pro); Churn annuale: 15–50% (Enterprise) - Tempo fino al primo cliente pagante: 3–9 mesi

Unit Economics (BASE): - Starter LTV: €5.000 | Professional LTV: €13.333 | Enterprise LTV: €144.000 - Cash CAC: €0 | LTV:CAC = infinito su base cash

Note per il relatore: Il nostro modello finanziario è conservativo. Il caso BASE porta €113K in 24 mesi — senza budget marketing, senza team di vendite, solo tempo del founder. Non è un "diventeremo unicorni". È un "dimostriamo che i centri sono disposti a pagare, prima di bruciare denaro". Il caso BULL mostra cosa è possibile se il passaparola virale funziona. La sensibilità è alta su churn e tempo al primo cliente — quelle sono le leve che controlliamo.

Slide 11: La Richiesta — Impiego dei Fondi

Cercato: Round Angel / Pre-Seed per accelerare da zero-bootstrap ai primi 10 clienti paganti

Impiego dei Fondi	Quota	Scopo
Sicurezza & Compliance	30%	Audit SOC 2 Type II, rimedio gap GDPR, penetration testing
Engineering	35%	Integrazione FHIR, hardening multi-tenant, modulo donatore vivente
Sales & Support Pilota	20%	Prima assunzione CSM, metriche successo pilota, produzione case study
Legale & Operazioni	15%	DPIA GDPR, contratti, costituzione, assicurazione cyber

Metriche di successo per questo round: - 10+ clienti paganti in 3+ centri trapianti - €5K+ MRR - Net Revenue Retention >100% - SOC 2 Type II report pulito - 1 case study pilota pubblicata con dati di miglioramento time-to-listing

Contatti: - E-mail: [investors@nephroassist.com] - LinkedIn: [linkedin.com/company/nephroassist] - Sito: [nephroassist.com]

Note per il relatore: Non cerchiamo un round da 10 milioni. Cerchiamo un investimento Angel o Pre-Seed che ci porti da "potrebbe funzionare" a "funziona". L'impiego principale è compliance e sicurezza — questo è il requisito di ingresso per ogni cliente ospedaliero. Il 35% va in Engineering per costruire l'integrazione FHIR e il modulo donatore vivente. Il 20% in Sales per finanziare il primo Customer Success Manager. Misuriamo il successo non sui numeri di utenti. Lo misuriamo sui clienti paganti, l'MRR e un report SOC 2.

Dati di mercato da CNT, Ministero della Salute, Eurotransplant, NHSBT e ispezione live dei siti concorrenti. Le proiezioni finanziarie sono strumenti di scenario-planning, non previsioni. Le ipotesi sono documentate esplicitamente nel Zero-Budget Financial Model.